

Strategisch Advies: Implementatie van Hybride Dagstructuurondersteuning voor Zorgbestuurders

1. Strategische Context: De Noodzaak van Hybride Transformatie

De Nederlandse zorgsector staat voor een onvermijdelijke transitie. De groeiende kloof tussen de zorgvraag en de beschikbare personeelscapaciteit dwingt ons tot een strategische herbezinning. Hybride transformatie is hierbij geen facultatieve innovatie, maar een noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van zorg te borgen en de eigen regie van cliënten te herstellen. De kern van 'Hybride Dagstructuurondersteuning' is volgens het Kenniscentrum Digitale Zorg niet het simpelweg inzetten van een hulpmiddel, maar een fundamenteel herontwerp van het primaire zorgproces. Het verschuift de focus van fysieke aanwezigheid voor herhalende taken (zoals herinneringen) naar een proces waarbij technologie de cliënt activeert en de zorgverlener enkel intervineert wanneer nodig. Deze verschuiving is cruciaal om de zorgverlener weer in de rol van expert te zetten in plaats van een 'digitale klok'. Om deze visie te operationaliseren, is een scherpe typering van de beschikbare technologie vereist.

2. Typologie en Doelgroepbepaling

Een succesvolle implementatie begint bij de juiste match tussen cliëntbehoefte en technologisch subtype. Een mismatch leidt onvermijdelijk tot onbenutte capaciteit en weerstand in de teams. Binnen hybride dagstructuurondersteuning onderscheiden we vier subtypen:

- **Niet-interactief beeldscherm:** Een digitale dagkalender (bijv. Nedap Luna) die herinneringen toont via tekst en symbolen, eventueel ondersteund door geluid of een avatar.
- **Interactief beeldscherm:** Een tablet met een vereenvoudigde interface, inclusief portalen voor mantelzorgers en mogelijkheden voor beeldzorg op afstand.
- **Sociale robot:** Een device met menselijke kenmerken (bijv. Tinybots Tessa) dat herinneringen uitspreekt en sociale interactie aangaat om de cliënt psychologisch te ondersteunen.
- **Combinatie:** Een geïntegreerde oplossing waarbij een interactief scherm is ingebed in een robotvorm, wat zowel visuele als verbale ondersteuning biedt. Voor een effectieve inzet is de **"Inzetwijzer"** het leidende instrument voor triage. De doelgroep omvat cliënten met geheugenverlies (dementie, NAH, Korsakov) of psychische aandoeningen. Cruciaal bij de selectie is de leesvaardigheid (voor schermen) en de mate van herinneringsopvolging. Waar een fysieke feedbackloop vereist is (zoals een bevestigingsknop bij medicatie), dient een medicijndispenser als aanvulling of alternatief te worden overwogen. Deze triage vormt de opmaat naar een fundamenteel andere werkwijze.

3. De Transitie: Van Traditionele naar Hybride Werkwijze

De overgang naar hybride zorg markeert een paradigmaverschuiving in de rol van de zorgverlener: van uitvoerder van herinneringen naar regisseur van het zorgproces. | Domein | Traditionele werkwijze | Hybride werkwijze || ----- | ----- | ----- || **Werkwijze** | Fysieke aanwezigheid voor begeleiding en verbale herinneringen. | Technologie biedt herinneringen, stelt vragen en geeft instructies. || **Planning** | Vaste zorgmomenten op basis van de

medewerkersroute. | Flexibele planning; herinneringen afgestemd op de situatie van de cliënt. || **Informatievoorziening** | Handmatige inplanning op basis van het ECD. | Koppeling ECD en technologie; automatische updates voor de cliënt. || **Regie/Eigenaarschap** | Zorgmedewerker leidt en controleert ter plaatse. | Cliënt voert zelfstandig uit; medewerker monitort op afstand. |

Strategische Analyse: De "So What?" van de Transitie Deze verschuiving verandert de controlefunctie fundamenteel. De zorgmedewerker wordt ontlast van routinematige controlebezoeken. Echter, dit heeft enkel strategische waarde als de routeplanning hierop wordt aangepast. Zonder actieve route-reorganisatie leidt de technologie enkel tot een lagere werkdruk zonder dat de zorgcapaciteit daadwerkelijk toeneemt. De focus moet daarom liggen op de specifieke oplossingen die deze efficiëntie ontsluiten.

4. Evaluatie van Marktconforme Oplossingen: Nedap Luna & Tinybots Tessa

De keuze voor leveranciers moet gestoeld zijn op waardebepalend onderzoek door Vilans en het Kenniscentrum Digitale Zorg, waarbij veiligheid en procesintegratie centraal staan.

Nedap Luna

Nedap Luna biedt een hoge strategische waarde door de directe koppeling met Nedap Ons/Caren. Dit minimaliseert de administratieve last. Onderzoek rapporteert een gemiddelde tijdsbesparing van 4 uur per cliënt per maand. **Belangrijke waarschuwing voor de businesscase:** deze besparingen op verschillende gebieden (medicatie en voeding) zijn *niet cumulatief*. Het simpelweg optellen van uren per inzetgebied leidt tot een vertekend beeld van de werkelijke tijdswinst.

Tinybots Tessa

Tessa fungeert als een psychologische interventie voor cliënten met initiatiefverlies (apathie) bij dementie. Door de sociale connectie ("maatje") wordt de drempel tot actie verlaagd. De gerapporteerde tijdsbesparing varieert van 38 tot 216 minuten per week, sterk afhankelijk van de hoeveelheid overgenomen zorgdoelen. Tessa's kracht ligt in de verbale ja/nee-interactie die een basale vorm van terugkoppeling geeft. **Technische Randvoorwaarden:** Beide systemen vereisen een stabiele WiFi- of 4G-verbinding en voldoen aan NEN 7510 en ISO 27001 certificeringen. Deze robuustheid is de basis voor onze organisatorische KPI's.

5. Strategische Impact op KPI's: Kwaliteit, Toegankelijkheid en Betaalbaarheid

Wij hanteren de zes KPI's van het Kenniscentrum Digitale Zorg om de impact te evalueren:

1. **Kwaliteit van Zorg:** De zelfredzaamheid bij medicatie en voeding neemt meetbaar toe. *Let op:* Hoewel zorgprofessionals verbeteringen in welzijn en rust rapporteren, is dit bewijs momenteel kwalitatief en anekdotisch; expliciete metingen ontbreken.
2. **Toegankelijkheid:** De zorgcapaciteit wordt direct vergroot. Voor elke vier ingezette Tessa's kan één extra cliënt in zorg worden genomen.
3. **Kosten en Capaciteit (Betaalbaarheid):** De harde baten (minder reiskosten, minder zorgminuten) staan tegenover exploitatiekosten (€49,50 p.m. voor Luna; €84,- p.m. huur voor Tessa).
4. **Bereik:** Het potentieel in de wijkverpleging wordt geschat op 9% tot 13%.
5. **Verzilvering:** De meest kritische KPI. Bespaarde tijd heeft pas waarde als routes worden ingekort of nieuwe cliënten worden aangenomen.

6. **Duurzaamheid:** Reductie van milieu-impact door minder reisbewegingen (gemiddeld 7,6 km besparing per week bij volledige vervanging van zorgmomenten).

6. Financieringsstructuur en Bekostigingsbronnen

Het Nederlandse financieringslandschap voor zorgtechnologie is complex en nog volop in beweging.

- **Reguliere bekostiging:** Beschikbaar via Zvw (prestatie thuiszorgtechnologie) en Wlz (MPT/VPT/Intramuraal).
- **Implementatiemiddelen:** Voor eenmalige kosten kan worden gekeken naar transitiemiddelen en ZonMw-subsidies.
- **Strategisch Voorbehoud:** Middelen vanuit de programma's **WOZO** en **TAZ** zijn op dit moment nog *niet direct beschikbaar*. De inzet hiervan vereist proactieve regionale onderhandeling met zorgkantoren. De huidige financiering is bovendien nog "niet eenduidig en consistent," wat we moeten adresseren via regionale lobby.

7. Geleerde Lessen en Strategische Routekaart

Succesvolle implementatie is 80% verandermanagement en 20% techniek.

1. **Verkenningfase:** Stel de 'waarom-vraag'. Gebruik de **Inzetwijzer** om de leercurve bij cliëntselectie te versnellen. Toon de technologie fysiek om weerstand in teams weg te nemen.
2. **Voorbereidingsfase:** Borg ICT-alignment en pas protocollen aan op de hybride werkwijze.
3. **Uitvoerings- en Opschalingsfase:** Wijs 'i-nurses' aan als ambassadeurs. Begin klein met één team en focus op concrete, herkenbare casussen in plaats van de technologie als 'duizenddingendoekje' te presenteren.

8. Conclusie en Advies voor het Bestuur

De transitie naar hybride dagstructuurondersteuning is essentieel voor een toekomstbestendige organisatie. Het biedt een antwoord op de arbeidsmarktkrapte en vergroot de autonomie van de cliënt.**Harde waarschuwing:** Het implementeren van de technologie zonder gelijktijdige aanpassing van de wijkroutes is een strategische misslag. Zonder route-optimalisatie vermindert de technologie enkel de werkdruk voor de huidige medewerkers ("het werk wordt wat rustiger"), maar wordt de noodzakelijke extra zorgcapaciteit niet ontsloten.**Call-to-actions voor het bestuur:**

1. **Geef een formele 'GO':** Stel budget beschikbaar voor een traject gericht op procesherontwerp en route-optimalisatie.
2. **Mandaat voor i-nurses:** Stel ambassadeurs aan met de expliciete taak en tijd om de werkwijze in de teams te veranderen.
3. **Proactieve dialoog met het Zorgkantoor:** Start direct gesprekken over de verzilvering van bespaarde tijd en de aanstaande WOZO/TAZ-middelen. Hoogachtend, Uw Senior Strategisch Adviseur Digitale Zorgtransformatie